의료진 진료 카드 · ASL-054

DXA 판독 · 유효 요추 전체를 사용

촬영과 분절 제외 사유를 확인한 뒤 L1~L4의 유효 부위 평균으로 판단한다.

요추 제외는 명확한 사유를 기록한다



본강의 · 측정의 적절성

촬영·장비	척추 중앙 정렬, T12~L5와 장골능·12번째 늑골 포함. 적절한 부위 해석과 장비 정도관리를 함께 본다.
제외 사유	압박골절·퇴행성 변화, 주변 요추와 T-score ≥1 SD 차이, 수술·철심·시멘트 등 인공물의 영향을 평가한다. 이상하면 측면 X-ray로 척추 자체의 문제를 확인한다는 연자 설명.

본강의 · 판독과 청구의 원칙

임의 선택 금지	낮은 두 분절만 골라 -2.5를 충족시키지 않는다. L1~L4 중 명확한 배제 사유가 있는 부위만 제외하고 남은 유효 부위는 전부 포함한다.
기록	2024-12-26 심사사례로 소개한 기준: PA 요추 평균과 최소 2분절, 각 제외 사유를 기록한다. 측면 촬영 결과는 경과 추적에는 사용 가능하나 진단에는 사용하지 않는다는 교재 설명.

본강의 · 분절 해석 예

L1~L4 −2.7 / −2.6 / −0.9 / 0.3	L3·L4의 퇴행성 변화가 제시되어 두 부위 배제, L1~L2로 진단.
L1~L4 −2.4 / −2.5 / −2.1 / −0.8	L4의 퇴행성 변화가 제시되어 L4 배제, L1~L3로 진단.

"차이 1"만으로 자동 제외할 분절을 결정하지 않는다. 해부학적 위치·골절·퇴행성 변화와 인공물, 인접한 유효 부위를 함께 보고 배제 사유를 기록한다.

의료진 진료 카드 · ASL-054

DXA 진단 · 검사일과 치료일 확인

T-score 진단 분류와 강의의 검사·청구 일정 설명

검사와 데노수맙 날짜가 다를 때의 강의 예시

2025.01.01
기존 DXA 검사일

→

2025.08.01
마지막 데노수맙 투여

→

2026.02.01 이후
마지막 투여 6개월 후
추적 DXA 시점

본강의 · T-score 진단 대상과 부위

대상·분류	폐경 후 여성·50세 이상 남성. 정상 ≥−1.0, 골감소 −2.5<T<−1.0, 골다공증 ≤−2.5, 중증 골다공증은 ≤−2.5 + 골절.
부위	요추·대퇴경부·전체 고관절 중 하나라도 해당하면 진단. 대퇴 전자부 단독 진단은 사용하지 않는다는 교재 설명.
양측 고관절 · 연자 Q&A	좌·우 대퇴경부 또는 전체 고관절 중 가장 낮은 T-score 사용. 양측 평균은 진단에 사용하지 않는다.

본강의 · 검사 적응증과 추적 간격

검사 적응증	여성 ≥65세·남성 ≥70세; 고위험요소가 있는 65세 미만 폐경 여성; 비정상 무월경 ≥1년; 취약골절; 골다공증 유발 질환/약물; 기타 필수 사유.
고위험요소	BMI <18.5, 비외상성 골절 과거력·가족력, 수술 폐경 또는 40세 이전 자연 폐경.
검사 간격	원칙 1년(365일). 불가피한 조기 검사는 4주 이내이며 사유를 기록한다. 데노수맙 투여일과 다르면 마지막 투여 6개월 후 평가로 설명했다.

연자 Q&A · 단일 분절과 유효 비교

단일 분절	L2 −3.1이어도 L1~L4 평균 −2.1이면 골감소증. 한 분절 T-score로 골다공증 진단·급여를 정하지 않는다는 답변.
Q&A 예	L1 −2.4, L2 −2.5, L3 −1.0, L4 −0.9: 연자는 L3·L4를 L2와 비교해 제외하고 L1~L2 평균으로 판단한다고 설명했다. 제외된 L3를 다시 비교 기준으로 쓰지 않았다.

검사 인정과 약제 급여는 구분한다. 강의는 DXA 또는 QCT를 진단·급여 도구로 소개했고 초음파(QUS)는 표준 진단 도구가 아니라 설명했다. 판독값뿐 아니라 측정 부위·제외 사유·검사일·주사일을 함께 기록한다.